ME/CFS-Mapping – Review-Notizen

Oct 31, 2026 · @Alexander Hallmann

So liest du das

Sammelstelle für alles, was du in `mecfs-criteria.xlsx` gegenlesen solltest. Wird nach jeder Section ergänzt. Jeder Punkt hat einen Typ:

- **Prüfen** – Zuordnung, bei der ich unsicher bin oder die du fachlich bestätigen solltest
- **Kompromiss** – bewusst vereinfacht zugunsten der Bedienbarkeit; psychometrisch/mechanistisch nicht ganz sauber
- **Hinweis** – Konsequenz für App-Design oder Auswertung, keine Mapping-Frage

Tab- und Item-IDs beziehen sich auf die xlsx (z. B. `Sec Immune`, `DSQ2-109`).

Übergreifend

Typ	Punkt	Konsequenz
Hinweis	**Gemessen vs. eingeschätzt:** Wearable-Puls/HRV (→ AU3) und Körpergewicht (→ NE7) haben kein Symptom-Item, hängen nur am nächstliegenden Granule.	Umgesetzt im Merge: eigene Leaves (Puls per Uhr/Sensor, Gewicht per Waage) mit Flag „measured, not rated“; 0 Instrument-Items, nie mit DSQ-Werten poolen.
Hinweis	**Check-in vs. periodischer Fragebogen:** Infekt-Items (IM5), Gewicht (NE7), Binär-Items der Falldefinition (z. B. DSQ2-101, -127, -129) ändern sich über Monate.	Nicht in tägliche EMA, sondern in periodische Fragebögen (z. B. monatlich). Schlaf-Items gehören in die Morgenabfrage.
Kompromiss	**Zwei-Pol-Granules:** EN1 (müde↔energiegeladen), MO1 (ängstlich↔ruhig), MO2 (niedergeschlagen↔glücklich), NE7 (ab↔zunehmen), IM5 (DSQ2-109 als Gegenpol).	Funktioniert nur, wenn die Richtungsfrage nach dem Leaf zuverlässig beantwortet wird.

Typ	Punkt	Konsequenz
Prüfen	**Abgefragte Facets** (Ausnahme von „Facets nie fragen“): Pain region, Function activity, Autonomic Blase, Temperature Schwitzen + Gewicht.	Jede Ausnahme verlängert den Baum um eine Frage. Gegenlesen, ob alle nötig sind.
Hinweis	**Measure type** unterscheidet sich je Instrument: DSQ = Häufigkeit/Schwere, FUNCAP = Kosten, RAND-36 = Einschränkung.	Gleiches Granule ≠ vergleichbare Werte. Pooling nur within-person standardisiert.
Hinweis	**Granules ohne Item:** MO4 Stress (CG9 hat seit DSQ-2 ein Item, 78).	Erreichbar im Baum, aber nur persönlich auswertbar.

Pro Section

Section	Typ	Punkt
Sensory	Prüfen	DSQ2-70 (verschwommen/Tunnelblick nach Aufstehen) = SN4 mit Trigger „standing“. Ein Score „verschwommen sehen“ matcht dadurch auch das orthostatische Item.
Sensory	Kompromiss	Gerüche/Chemikalien stehen im Baum unter „Sinne“, leiten aber auf IM6 um (Unverträglichkeit, keine Wahrnehmung).
Function	Prüfen	Strukturentscheidung: Aktivitäten (Duschen, Kochen, Einkaufen) sind keine Granules, sondern Facet „activity“ auf PF1–PF3. Dadurch fast alle FUNCAP A/D/F-Items Composite.
Function	Kompromiss	RAND-36 8 (Bücken/Knien) auf PF3 als nächstliegendes Granule; eigentlich Beweglichkeit + Haltungswechsel.
Function	Hinweis	PF5 Pacing ist Verhalten, keine Fähigkeit. Nur behalten, weil Nutzer es tracken.
Autonomic	Prüfen	GI und Blase in Autonomic statt eigener Sections (DSQ-Gruppierung, kurzer Baum). Mechanistisch ist z. B. Reizdarm nicht rein autonom.
Autonomic	Kompromiss	DSQ2-51 „Dizziness“ als Präsynkope gelesen, nicht als Drehschwindel.

Section	Typ	Punkt
Autonomic	Hinweis	POTS-Score wäre Composite AU1 + AU3; kein eigenes Granule.
Neuromuscular	Prüfen	DSQ2-49 (unsicher auf den Beinen) → NM4, obwohl DSQ es unter Autonomic führt. Ursache kann orthostatisch oder motorisch sein.
Temperature	Kompromiss	Schwitzen (NE5) und kalte Gliedmaßen (NE1) sind mechanistisch autonom, für Nutzer aber beim Temperatur-Cluster.
Temperature	Prüfen	NE8 Alkoholunverträglichkeit: Mechanismus unklar, nur DSQ-Gruppierung gefolgt.
Immune	Kompromiss	IM6 (Gerüche, Chemikalien, Schimmel) in Immune, weil DSQ es so gruppiert; immunologischer Mechanismus nicht belegt.
Immune	Prüfen	IM5 bündelt Häufigkeit, Erholung, Anfälligkeit und DSQ2-109 „keine Erkältungen mehr“ als Gegenpol.
Mood	Kompromiss	„Glücklich“ als Gegenpol zu „niedergeschlagen“ (MO2). Positive Affektivität und Depressivität sind teils getrennte Konstrukte; RAND-36 wertet MHI-5 aber als eine Skala.
Mood	Hinweis	MO4 Stress ohne Item, nur damit Stress-Scores nicht bei Angst (MO1) landen.

Global

Typ	Punkt
Hinweis	Der häufigste eigene Score („wie geht es mir heute insgesamt“) landet in GL1. Die passenden Items (RAND-36 1, 34, 36) fragen allgemein bzw. 4 Wochen ab → nur konzeptuell vergleichbar.
Hinweis	Bell = ein Item mit 11 Stufen (10er-Schritte): zu grob für tägliches Tracking, gut als periodischer Snapshot.
Hinweis	Änderungs-Items (PGIC, RAND-36 2) brauchen einen Anker (Protokollstart bzw. 1 Jahr). Gehören ans Blockende, nicht in EMA.

Typ	Punkt
Kompromiss	RAND-36 35 „I expect my health to get worse“ misst Erwartung, nicht Zustand. Trotzdem GL1, damit die General-health-Skala berechenbar bleibt; ebenso 33 als Composite mit IM5.
Prüfen	Die oberste Baumebene hat jetzt 12 Kategorien. Umgesetzt im Merge: 8 Bereiche + „mehrere“, siehe Abschnitt Merge.

Merge (Schritt 12)

Typ	Punkt
Prüfen	**N0-Gruppierung:** 12 Kategorien → 8 Bereiche + „Several of these areas“. Overall, Energy, Thinking, Sleep, Pain, Function, Mood bleiben oben; Senses, Muscles, Autonomic, Temperature, Immune liegen unter „Other body symptoms“ (BD-N1, +1 Frage). Max. 4 Fragen bis zum Leaf (+ Richtungsfrage). Reihenfolge = erwartete Häufigkeit eigener Scores.
Prüfen	**„Several of these areas“** an N0: Multi-Select, danach wird jeder gewählte Zweig durchlaufen. Bei 3+ Bereichen wird das lang – evtl. auf 2 Bereiche begrenzen.
Prüfen	**Redirect „How mentally exhausted I get“** (Cognition) → jetzt direkt EN3 (mentale Ermüdbarkeit) statt Sprung in die Energy-Section. Falls eher der Crash nach geistiger Anstrengung gemeint ist, wäre EN4 richtig.
Prüfen	**DSQ2-2 (Körpergewicht)** ist als demografisch geführt, wäre aber das passende Item für den Leaf „My weight itself (from a scale)“ (NE7). Mappen oder demografisch lassen?

Typ	Punkt
Kompromiss	**Facet-Matching bei abgefragten Facets:** Ein Item matcht, wenn es denselben Wert hat, „unspecified“ ist oder gar kein Facet dieses Knotens trägt. Folge: RAND-36 21 (Schmerz allgemein) matcht jede Region, DSQ2-46 (Blase allgemein) matcht „Drang“ und „nachts“. Ausnahme „activity“ (strikt): nur Items mit genau dieser Aktivität.
Hinweis	**Dedupe:** 6 Items standen in zwei Tabs (DSQ2-15, -18, -70; F55-32, -52; R36-33). Keine Widersprüche, nur unvollständige Listen; jetzt Union, z. B. DSQ2-15 = EN4 + PN1, F55-32 = CG2/4/7 + SN2.
Hinweis	**Coverage:** 247 Outcome-Items (DSQ-2, FUNCAP55, RAND-36, Bell, PGIC): 197 gemappt (35 Composite), 11 ausgeschlossen, 39 keine Outcomes (Demografie, Anamnese, Ausschluss, Attribution, 119-Stem), 0 unbehandelt. Einziges Granule ohne Item: MO4. Bell/PGIC zählen jetzt in allen Coverage-Spalten.
Hinweis	Neue Tabs `All granules`, `All items`, `Full tree` werden von `merge.py` erzeugt – Änderungen immer in `sections.py`, dann beide Skripte laufen lassen.

Entscheidungen zum Gegenlesen

Thema	Entscheidung	Begründung
DSQ2-75 Muskelermüdung nach leichter Aktivität	EN2 (Ermüdbarkeit)	Kraftverlust durch Nutzung, keine systemische Verschlechterung; PEM = 76/77; konsistent mit DSQ-1 17
DSQ2-79 verlangsamtes Sprechen	nur CG3	Misst Tempo, nicht Formulierung (CG7); kein Sprechmotorik-Item in irgendeinem Instrument

Thema	Entscheidung	Begründung
PGIC-Stem	„Since you started '<protocol name>', how has your overall condition changed? (Think of your symptoms, your energy and what you can manage day to day.)“	Anker Protokollstart (PGI-I-Logik); Domänen nach Hurst & Bolton verdichtet; ohne Diagnosename
GI + Blase	Teil von Autonomic (AU5–AU8)	DSQ-Gruppierung; oberste Baumebene bleibt kurz
Neuromuskulär	eigene Section (NM1–NM4)	anderer Mechanismus als autonom

Noch offen

- [ ] „Rules added after pilots“ im Tab `Method` gegenlesen (inkl. neuer Regel „Facet activity“)
- [ ] FUNCAP: Höflichkeits-Mail an die Autoren
- [ ] Bell: Nutzungsbedingungen verifizieren
- [ ] Merge-Entscheidungen (Abschnitt Merge, Typ „Prüfen“) gegenlesen